

Bandelette urétrale masculine

Information pour le patient · Une bandelette pour traiter les fuites urinaires après prostatectomie

WARWIKI

La bandelette urétrale masculine (sling) est une fine bandelette synthétique placée sous l'urètre (le canal par lequel l'urine s'écoule) pour traiter l'incontinence urinaire d'effort — les fuites à l'effort, à la toux ou au port de charges, souvent consécutives à une prostatectomie. Elle soulève et soutient l'urètre afin d'améliorer le contrôle urinaire. Contrairement au sphincter artificiel, aucun mécanisme n'est à actionner.

À propos de cette intervention

Les fuites urinaires à l'effort, à la toux ou au port de charges — appelées **incontinence urinaire d'effort** — surviennent fréquemment après une prostatectomie. La bandelette y remédie en plaçant une fine bandelette synthétique sous l'urètre pour le remonter vers sa position normale.

Elle **soutient** l'urètre sans le comprimer, de sorte qu'une fois guéri vous **urinez normalement** — il n'y a ni pompe, ni bouton, ni dispositif à manipuler.

Ce qu'il faut savoir

La bandelette est la plus efficace pour les fuites **légères à modérées** chez les hommes conservant une certaine fonction sphinctérienne, vérifiée au préalable. En cas de fuites importantes ou d'antécédent d'**irradiation pelvienne**, un **sphincter urinaire artificiel** est généralement préférable — votre chirurgien vous guidera. La bandelette peut **réduire** les fuites sans les supprimer totalement ; si elle est insuffisante, un sphincter peut être posé ultérieurement.

COMPRENDRE LES TERMES

Incontinence urinaire d'effort

Fuites urinaires à l'effort, à la toux ou au port de charges.

Urètre

Canal qui évacue l'urine hors de l'organisme.

Bandelette (sling)

Fine bandelette synthétique placée sous l'urètre pour le soulever et le soutenir.

Vérification du repositionnement

Examen endoscopique confirmant que soulever l'urètre devrait améliorer la continence.

Rétention urinaire

Difficulté temporaire à vider la vessie après l'intervention ; une sonde peut être nécessaire brièvement.

Sphincter artificiel (SUA)

Dispositif alternatif avec pompe, utilisé surtout pour les fuites importantes.

Anesthésie générale

Médicaments qui vous endorment et suppriment la douleur pendant l'opération.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'opération se déroule sous anesthésie générale ou rachianesthésie : vous ne sentez rien. Ensuite, l'aine et le périnée sont douloureux, gonflés et marqués d'ecchymoses pendant une à deux semaines — glace, suspensoir et antalgiques soulagent. L'opération dure environ une heure ; beaucoup rentrent le jour même.

Comment vous préparer (Avant l'opération)

- Intervention sous **anesthésie générale ou rachianesthésie** — respectez toutes les consignes préopératoires (jeûne, médicaments à suspendre, dont les anticoagulants).
- Un **examen d'urine** dépiste toute infection (à traiter avant), et une **cystoscopie** confirme que la bandelette est indiquée.
- **Ne fumez pas**, contrôlez votre poids et votre diabète, et prenez les antibiotiques prescrits — la bandelette est un implant synthétique.

Signalez à votre équipe à l'avance si vous :

- Avez eu une **irradiation pelvienne** — la bandelette est souvent moins efficace et un sphincter peut être préférable
- Avez subi une chirurgie de l'incontinence ou un rétrécissement urétral
- Présentez une infection, quelle que soit sa localisation

Déroulement de l'opération

- 1 Vous êtes endormi ou insensibilisé de la ceinture vers le bas sous anesthésie, et des antibiotiques vous sont administrés.
- 2 Par de petites incisions dans l'aine et le périnée, le chirurgien place la bandelette synthétique sous l'urètre et la remonte en position.
- 3 La bandelette est fixée, les incisions sont fermées et une sonde est généralement laissée en place brièvement.

Après l'opération

- Appliquez de la glace, portez un suspensoir et prenez des antalgiques pour la douleur, le gonflement et les ecchymoses (1–2 semaines).
- **Évitez les efforts, la poussée, le vélo et les rapports sexuels** pendant plusieurs semaines (environ 6) — forcer peut déplacer la bandelette avant cicatrisation.
- Des **difficultés urinaires transitoires** peuvent nécessiter une sonde temporaire.
- Portez des protections au début — l'amélioration est progressive. **Rien à actionner** ; une fois guéri, vous urinez normalement.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Une **impossibilité totale d'uriner**
- De la fièvre ou des frissons, ou une rougeur, douleur ou écoulement croissant au niveau d'une incision
- Des douleurs inguinales ou périnéales s'aggravant

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La bandelette urétrale masculine est placée sous l'urètre pour le soulever et améliorer la continence après prostatectomie — rien à actionner.
2. Elle est la plus efficace pour les fuites **légères à modérées** ; pour des fuites importantes ou après irradiation, un sphincter artificiel est généralement préférable (posable plus tard).
3. Après l'opération, **évitez les efforts, la poussée, le vélo et les rapports sexuels** plusieurs semaines pour que la bandelette se fixe. Des difficultés urinaires transitoires sont possibles.